ESCALA DE IDEACIÓN SUICIDA DE BECK (BSS)

Beck, A. T., Kovacs, M., & Weissman, A. (1979) · Beck, A. T., & Steer, R. A. (1991) · Adaptación española: Bobes et al. (2004)

Paciente / Código:	**Edad:**	**Fecha:**
Evaluador / Servicio:	**Sexo:** [ ] F [ ] M **Nº Historia / Cód:**	**Ámbito:** [ ] Urgencias [ ] Consulta [ ] Hospital

INSTRUCCIONES: Cada ítem presenta tres opciones graduadas (0, 1 o 2). Elija la opción que mejor describa sus sentimientos o pensamientos **durante la última semana y en el momento actual**. Responda primero a los ítems 1 a 5 (Fase 1). Preste atención a la indicación al final del ítem 5.

PARTE 1: DESPISTAJE INICIAL / CRIBADO DE IDEACIÓN SUICIDA

1. Deseo de vivir

- 0 Moderado a fuerte.
- 1 Débil.
- 2 Ninguno.

2. Deseo de morir

- 0 Ninguno.
- 1 Débil.
- 2 Moderado a fuerte.

3. Razones para vivir frente a razones para morir

- 0 Las razones para vivir tienen más peso que las de morir.
- 1 Las razones para vivir y morir son iguales.
- 2 Las razones para morir tienen más peso que las de vivir.

4. Deseo activo de realizar un intento de suicidio

- 0 Ninguno.
- 1 Débil.
- 2 Moderado a fuerte.

5. Intento pasivo de suicidio / Evitación de la muerte

- 0 Tomaría precauciones activas para salvar mi vida en caso de peligro.
- 1 Dejaría la vida o la muerte al azar (no tomaría precauciones activas).
- 2 Evitaría deliberadamente cualquier medida para salvarme o mantener la vida.

REGLA DE FILTRO / SCREENING GATE: • Si en **ambos ítems 4 y 5** la respuesta es **0**, interrumpa la Parte 2 y pase directamente al **Ítem 20** (pág. 2).
• Si en el **ítem 4 O en el ítem 5** la puntuación es **1 o 2**, es **OBLIGATORIO** responder a todos los ítems de la Parte 2 (ítems 6 al 19).

PARTE 2: IDEACIÓN SUICIDA ACTIVA Y PLANIFICACIÓN (Ítems 6 al 12)

6. Frecuencia de la ideación suicida

- 0 Rara o fugaz.
- 1 Ocasional o periódica.
- 2 Continua o casi continua.

7. Duración de los pensamientos de suicidio

- 0 Períodos muy breves o pasajeros.
- 1 Períodos prolongados de tiempo.
- 2 Casi todo el tiempo de forma continua.

8. Actitud hacia los pensamientos de suicidio

- 0 Rechazo activo / los considera inaceptables.
- 1 Ambivalencia (los acepta y rechaza a la vez).
- 2 Aceptación plena / los acoge con agrado.

9. Control sobre los pensamientos / actos de suicidio

- 0 Tiene control absoluto sobre sí mismo.
- 1 Duda de si podrá mantener el control.
- 2 Siente que no tiene control sobre sus impulsos.

10. Frenos disuasorios (familia, religión, dolor)

- 0 No lo intentaría por frenos claros (familia, creencias).
- 1 Le preocupan los frenos, pero influyen poco.
- 2 Los frenos disuasorios no tienen ninguna influencia.

11. Razones para el intento suicida contemplado

- 0 Manipular a otros, conseguir atención o ayuda.
- 1 Combinación de manipulación y escape.
- 2 Exclusivamente escapar de una situación intolerable.

12. Método: Especificidad y planificación

- 0 No ha pensado en ningún método concreto.
- 1 Ha pensado en un método pero sin detalles precisos.
- 2 Tiene un plan específico y detallado ya elaborado.

PARTE 2: IDEACIÓN SUICIDA ACTIVA Y PLANIFICACIÓN (Continuación: Ítems 13 al 19)

13. Método: Disponibilidad y acceso a los medios

- 0 El método no está accesible ni disponible.
- 1 El método requeriría tiempo o esfuerzo para obtenerlo.
- 2 El método o medio letal está inmediatamente disponible.

14. Sensación de capacidad / coraje para actuar

- 0 No tiene el coraje, capacidad o resolución necesaria.
- 1 Inseguro respecto a si tendría el valor de hacerlo.
- 2 Completamente seguro y decidido a llevarlo a cabo.

15. Expectativa real de realizar el intento

- 0 No espera llevar a cabo el intento.
- 1 No está seguro de si lo llevará a cabo o no.
- 2 Espera y anticipa firmemente realizar el intento.

16. Preparativos para el intento suicida

- 0 Ningún preparativo realizado.
- 1 Preparativos parciales (guardar pastillas, buscar info).
- 2 Preparativos completos terminados (adquisición de medios).

17. Nota o carta de despedida

- 0 No ha pensado ni redactado ninguna nota.
- 1 Ha pensado en escribirla o tiene notas incompletas.
- 2 Ha redactado completamente una carta o nota de despedida.

18. Actos finales (testamento, seguro, regalar bienes)

- 0 No ha tomado ninguna disposición final.
- 1 Ha pensado en ordenar sus asuntos o regalado cosas.
- 2 Ha tomado disposiciones firmes (testamento, despedidas).

19. Ocultación deliberada o engaño sobre el plan

- 0 Ha revelado sus ideas de suicidio de forma abierta.
- 1 Ha sido reticente o esquivo para hablar del tema.
- 2 Ha intentado engañar activamente o negar para ocultarlo.

PARTE 3: TENTATIVAS PREVIAS DE SUICIDIO (Sección complementaria · No computa en total 0-38)

20. Número de tentativas de suicidio previas

- 0 Ninguna tentativa previa a lo largo de su vida.
- 1 Una tentativa previa.
- 2 Dos o más tentativas de suicidio previas.

21. Letalidad médica del intento previo más grave

- 0 No hubo intento previo o no requirió atención médica.
- 1 Lesiones leves o moderadas (hospitalización breve).
- 2 Lesiones graves con riesgo vital inminente (UCI/reanimación).

CÓMPUTO DE PUNTUACIÓN, BAREMOS Y DECISIÓN CLÍNICA (USO PROFESIONAL)

Fase 1: Despistaje (Ítems 1 al 5)	_____ / 10
Fase 2: Ideación Activa (Ítems 6 al 19)	_____ / 28
PUNTUACIÓN TOTAL BSS (Ítems 1-19)	_____ **/ 38**
Tentativas Previas (Ítems 20 y 21)	Intentos: ____ | Letal.: ____

Puntuación BSS	Nivel de Riesgo y Acción Clínica
0 puntos	Sin ideación activa demostrable.
1 - 5 puntos	Riesgo leve / pasivo. Monitorización.
6 - 15 puntos	Riesgo moderado. Plan de seguridad.
16 - 38 puntos	Riesgo grave inminente. Derivación urg.

PROTOCOLO DE URGENCIA ANTE RIESGO AUTOLÍTICO: Cualquier puntuación > 0 en la BSS, o la presencia de tentativas previas con alta letalidad (ítem 21 = 2) o preparativos completados (ítem 16 = 2) exige: 1) NO dejar al paciente solo; 2) Retirada inmediata del acceso a medios letales; 3) Contacto con red de apoyo familiar; 4) Derivación inmediata al servicio de Psiquiatría de Urgencias.